Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Osório

Av. Jorge Dariva, 1191 - Bairro: Centro - CEP: 95520000 - Fone: (51)-30985197 - Email: frosorio1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007111-39.2022.8.21.0059/RS

AUTOR: LUIS EDUARDO DA SILVA MARTINS
RÉU: MUNICÍPIO DE OSÓRIO
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

I – Relatório (artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil):

LUIS EDUARDO DA SILVA MARTINS ajuizou a presente ação em face do **MUNICÍPIO DE OSÓRIO e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Narrou que é portador de Carcinoma Hepatocelular (CID 10: C22), após ter realizado transplante de fígado, em abril de 2019. Disse que, em julho de 2021, apresentou progressão da doença, com linfonodomegalia em tronco celíaco, sendo realizado resseção, confirmando metástase de CHC, e que, em julho de 2022, apresentou nova progressão da doença, com metástase óssea, sendo, por isso, necessário o início do tratamento com Sorafenibe (Nexavar) na dose de 400mg 12/12**,** uso contínuo, por prazo indeterminado. Discorreu sobre o direito. Postulou pela concessão de tutela de urgência sob pena de bloqueio de valores. Requereu a procedência da demanda e a concessão da gratuidade da justiça. Juntou documentos (Evento 01).

Foi determinada a emenda da incial, com a inclusão da União Federal, e posterior remessa dos autos à Justiça Federal (evento 3, DESPADEC1).

A Justiça Federal, determinou a exclusão da União Federal do polo passivo, e a devolução dos autos à Justiça Estadual.

A inicial foi recebida, deferida a gratuidade da justiça, e concedida a tutela de urgência (evento 23, DESPADEC1).

O Município de Osório, regularmente citado, ofereceu contestação no evento 52, CONT1, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou inexistir amparo legal para a condenação. Outrossim, discorreu sobre o modelo de atenção básico de saúde, bem como sobre o princípio da interdependência dos poderes. Defendeu a impossibilidade de bloqueio de valores em contas bancárias dos entes públicos. Requereu, assim, o acolhimento da preliminar suscitada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. Em caso de entendimento diverso, requereu a improcedência da ação.

O Estado do Rio Grande do Sul, igualmente citado, ofereceu contestação no evento 53, CONT1.Disse da necessidade do fármaco ser prescrito pela Denominação Comum Brasileira e do caráter vinculante das decisões dos tribunais superiores sobre o tema. No mérito, referiu que o autor não preenche os requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, a comprovação médica da imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira da parte de custeá-lo e a existência de registro na ANVISA. Aduziu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, vez que o medicamento pretendido pelo autora não se encontra padronizada no SUS e destina-se a tratamentos oncológicos. Pontuou que cabe à parte autora a apresentação de receituário atualizado a cada seis meses e alegou o não cabimento de fixação de multa diária por eventual descumprimento de medida liminar. No mais, discorreu acerca da matéria de direito que entende aplicável ao caso. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

A requerimento do Estado do Rio Grande do Sul, foi determinada a expedição de ofício ao Hospital Conceição (evento 73, DESPADEC1), que foi respondido no evento 76, RESPOSTA1.

Oportunizada vista as partes, não houve manifestação.

O Ministério Público, com vista, declinou a intervenção (evento 83, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório.

Decido.

II – Fundamentação (artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil):

2.1 Preliminares:

<u>2.1.1 Da alegada ilegitimidade do Município de Osório:</u>

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Município de Osório, em razão da ausência de inclusão dos medicamentos solicitados nas listas previamente elaboradas pelo SUS, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado, seja qual for a esfera de poder – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pois possuem competência comum, a teor do art. 23, II, da CF –, assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades, especialmente as mais graves.

Ademais, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o acesso à saúde.

Assim, não importa que o medicamento postulado não esteja nas listas de medicamentos excepcionais, essenciais ou de atenção básica, elaboradas pelo Ministério da Saúde, pois a responsabilidade solidária impõe que sejam envidados esforços para a completa prestação pretendida, mesmo que para isso tenham o Estado e Município que arcar com os custos respectivos. Nesse sentido:

> *REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESNECESSIDADE DA PREVISÃO DOS MEDICAMENTOS NAS LISTAS ESPECÍFICAS. I - O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes.* ***Trata-se de responsabilidade solidária, e o cidadão pode demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente****. Arts. 198, § 1º, da Constituição da República; 241 da Constituição Estadual; e 7º, XI, da Lei Federal nº 8.080/90. Repercussão Geral nº 855.178/SE do STF. II - O direito à saúde é direito social e dever do Estado - arts. 6º e 196 da CF/88 -, e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do art. 5º, §1º, da Constituição da República. III -* ***Desnecessária a previsão em lista de medicamentos essenciais ou especiais ou excepcionais da Administração, pois atos normativos não se sobrepõem à norma constitucional.*** *Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70069734457,* ***Terceira Câmara Cível****, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em* ***05/05/2017****).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 2.* ***Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.*** *3. Descabe ao Poder Judiciário avaliar acerca da efetividade dos medicamentos prescritos para o caso clínico do paciente, posto que somente o profissional que assiste o caso possui os elementos necessários para determinar qual o tratamento apropriado para extinguir ou mitigar a doença, sendo o responsável pela indicação dos fármacos e seus efeitos no combate à patologia diagnosticada. 4. É inviável a substituição dos fármacos prescritos para parte autora, pois o médico que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade diagnosticada, não podendo prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido pelos técnicos da SES que sequer tiveram contato com o doente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70073232415,* ***Primeira Câmara Cível****, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em* ***05/05/2017****).*

Enfim, em se tratando de responsabilidade solidária, pode a parte requerente demandar contra quaisquer dos entes, seja União, Estado, seja Município e, em caso de condenação, o ente poderá buscar ressarcimento com a União administrativamente ou em demanda própria, se assim entender necessário.

Pelo exposto, rejeito a prefacial, passando a analisar o mérito da presente demanda, que, adianto, merece parcial procedência.

2.1.2 Da Denominação Comum Brasileira

Imperioso destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo (*Apelação Cível, Nº 70084379239, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020*).

Neste mesmo sentido é o Enunciado nº 15 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor:

> *As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.*

2.1.3 Da competência

A questão da competência está superada pela decisão de tutela incidental proferida no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234.

Segue o dispositivo da decisão, exarada em 17.04.2023 e confirmada pelo Plenário Virtual do STF, em 18.04.2023:

> *(i)* ***nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:*** *a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> *(ii)* ***nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados****: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (grifos acrescidos)*

*(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos **sem sentença prolatada**; diferentemente, os processos **com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)** devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Neste caso, verifico que o medicamento Sorafenibe não está incorporado ao SUS. Além disso, a parte autora ajuizou a demanda judicial direcionando o feito ao Juízo Estadual, portanto, incide o item *ii* do Tema 1234 do STF.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

2.2. DO MÉRITO

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal. Neste sentido: RE nº 557.548/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 155, publicado em 05.12.2007.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível Nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que ao Judiciário compete fazer cumprir a ordem jurídica.

2.2.1 Da necessidade do tratamento

A necessidade de tratamento está evidenciada no laudo médico subscrito por três especialistas da área de oncologia, confomre se observa do evento 1, ATESTMED5, onde restou consignado os benefícios do tratamento, e que a ausência pode acarretar a morte. Veja-se o trecho abaixo:

> Paciente no momento assintomático (ECOG 0), com doença hepática controlada. Visto o acima relatado, o paciente tem indicação de receber medicação Sorafenibe (Nexavar) na dose de 400mg 12/12. O tratamento deve ser contínuo até evidência de progressão de doença ou toxicidade inaceitável. A expectativa de benefício com a citada intervenção baseia-se nos resultados do SHARP trial, que demonstrou ganho de sobrevida global na comparação com o placebo. O perfil de tolerabilidade é compatível com o uso em pacientes com hepatopatia crônica. A sua ausência, ou demora na instituição do tratamento, aumenta o risco de sintomas e morte. Não há disponibilidade de medicação similar e/ou genérica para tal situação.

Ademais, foi juntado ao feito a **negativa administrativa** da Farmácia Pública do Estado e do Município (evento 1, DECL7 e evento 1, DECL8).

No caso dos autos, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos.

O primeiro requisito ficou comprovado pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, ATESTMED5 e evento 1, ATESTMED4, Página 1), que refere à necessidade no uso do medicamento **Sorafenibe 400 mg, de 12/12,** para o tratamento da doença "carcinoma de células hepáticas" (CID10 C22).

O segundo requisito, consistente na insuficiência econômica de arcar com os custos do tratamento, vem amparado no valor da medicação (evento 1, ANEXO9), nos comprovantes de renda que embasaram o deferimento da gratuidade da justiça.

Ademais, também preenchido o último requisito, qual seja, registro na ANVISA.

Diante das alegações da parte autora, corroboradas pela documentação juntada aos autos, restou evidente a sua necessidade em receber o tratamento pleiteado, pois indispensável à manutenção de sua saúde.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos por LUIS EDUARDO DA SILVA MARTINS contra o MUNICÍPIO DE OSÓRIO e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para confirmar a tutela de urgência (evento 23, DESPADEC1) e determinar o fornecimento do medicamento **Sorafenibe,** com a periodicidade e dosagem determinada pelo médico, e por tempo indeterminado.

A prescrição médica deverá ser atualizada de seis em seis meses, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria Estadual da Saúde do RS – Farmácia de Medicamentos do Estado ou outro local - pois apesar da indicação de uso contínuo, há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado.

Isento os demandados do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno os demandados, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das **despesas processuais** NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como de **honorários sucumbenciais,** que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverão ser atualizados monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Publicação e intimações automáticas. Sem necessidade de registro.

Sendo interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Caso interposta apelação e havendo pedido de bloqueio de valores, considerando a necessidade de remessa dos autos à segunda instância, deverá a parte autora distribuir cumprimento provisório de sentença em autos apartados.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANO PEREIRA BREDA, Juiz de Direito**, em 11/10/2023, às 15:29:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10047781250v6** e o código CRC **f847d6d1**.